

ALERGIAS



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

URTICÁRIA

- **Introdução:**

A urticária é uma doença mediada pela ativação dos mastócitos com o surgimento rápido de **urticas, angioedema ou ambos.**

- **Epidemiologia:**

Até 20% das pessoas podem desenvolver urticária aguda em algum momento da vida e até 5%, urticária crônica.

Há predominância pelo sexo feminino.



URTICÁRIA

- **Etiologias:**

A etiologia **imune** é a mais prevalente, sendo **IgE dependente**.

É a responsável pelas alergias alimentares, medicamentosa, à picada de insetos e de contato.

Em menor prevalência, temos as etiologias autoimune, infecciosa, desencadeada por imunocomplexos e ativação do complemento.



URTICÁRIA

Quadro clínico:

- **Urtica:** a lesão urticariforme típica é uma placa eritematosa intensamente pruriginosa. Cada lesão desaparece individualmente em 30 minutos até 24 horas.
- **Angioedema:** edema profundo eritematoso ou normocrômico na derme, subcutâneo ou membrana mucosa. A sensação de dor, queimação ou pressão é mais importante que o prurido.



URTICÁRIA

- **Diagnóstico:** clínico!!

Não é necessário a realização de exames laboratoriais.

Observação: O tratamento será abordado detalhadamente no material de apoio de prescrições.



ANAFILAXIA

- **Definição:** reação alérgica grave!!
Baseia-se na presença de urticária associada a manifestações sistêmicas.

- **Etiologias: mediada por IgE**
Mais comuns a alimentos, medicamentos e picadas de insetos.

- **Epidemiologia:** corresponde a 1% dos atendimentos da emergência, porém é altamente letal nos casos em que há atraso na identificação e no tratamento.



ANAFILAXIA

Necessária a presença de pelo menos 1 dos 2 critérios abaixo:

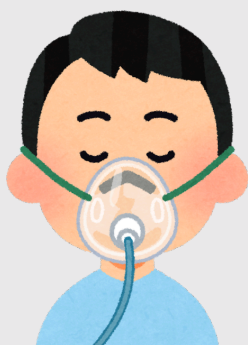
- **1º)** início agudo de uma doença com envolvimento da pele, mucosa ou ambos, associado a comprometimento respiratório, circulatório ou gastrointestinal grave.
- **2º)** início agudo de hipotensão, broncoespasmo ou envolvimento laríngeo após exposição a um alérgeno conhecido ou altamente provável mesmo na ausência de acometimento da pele.



ANAFILAXIA

O diagnóstico deve ser realizado de forma **precoce**, a fim de se instituir o tratamento o **mais rápido possível** no cenário de emergência.

O tratamento será abordado em detalhes no material de apoio de prescrição.



REFERÊNCIAS

- Anafilaxia e outras alergias - Medicina de Emergência da USP 17ª Edição.
- Urticária de início recente - UpToDate.
- Anafilaxia diagnóstico agudo - UpToDate.
- Anafilaxia: Tratamento de emergência - UpToDate.

